## Questions — rectos

### Carte 01

**Quelle différence essentielle distingue virus et bactéries ?**

### Carte 02

**À quelle famille appartiennent Candida et Aspergillus ?**

### Carte 03

**Que signifie le caractère opportuniste d'un agent ?**

### Carte 04

**Comment définir un microbiote ?**

### Carte 05

**Quels sont les deux éléments centraux d'une IAS ?**

### Carte 06

**Pourquoi le repère de 48 heures ne prouve-t-il pas une IAS ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 02

Ce sont des champignons. Candida est une levure et Aspergillus une moisissure.

### Carte 01

Le virus dépend de cellules hôtes. Une bactérie possède une organisation cellulaire propre.

### Carte 04

C'est l'ensemble des micro-organismes d'un milieu donné. Leur présence n'équivaut pas à une infection.

### Carte 03

Il profite de circonstances favorables. Immunodépression ou rupture de barrière peuvent permettre une infection.

### Carte 06

L'incubation et le lien aux soins restent déterminants. La chronologie est un repère, pas une preuve isolée.

### Carte 05

Le lien avec les soins et l'absence au début, y compris d'incubation. Le délai seul ne suffit pas.

## Questions — rectos

Carte 07

**Quel lien existe entre infection nosocomiale et IAS ?**

Carte 08

**Que comparent incidence et prévalence ?**

Carte 09

**Qu'est-ce qu'une infection d'origine endogène ?**

Carte 10

**Quels éléments faut-il relier dans une chaîne de transmission ?**

Carte 11

**Pourquoi entretenir le matériel partagé entre patients ?**

Carte 12

**Une bactérie dans les urines prouve-t-elle une infection à traiter ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 08

Nouveaux événements sur une période et événements présents à un moment donné. Dates et dénominateurs sont indispensables.

### Carte 07

Une infection nosocomiale est une IAS acquise en établissement de santé. Les IAS ont un périmètre plus large.

### Carte 10

Réservoir, sortie, transmission, entrée et hôte réceptif. La prévention peut agir sur plusieurs maillons.

### Carte 09

L'agent vient du patient lui-même. Son microbiote peut atteindre un site normalement protégé.

### Carte 12

Non. Le résultat s'interprète avec les signes, le site et les conditions du prélèvement.

### Carte 11

Il peut assurer une transmission indirecte. L'hygiène des mains ne désinfecte pas le dispositif.

## Questions — rectos

Carte 13

**Pourquoi combiner plusieurs mesures de prévention ?**

Carte 14

**Que rechercher avant de maintenir une voie veineuse inutilisée ?**

Carte 15

**Quels types d'anomalies surveiller sur une VVP ?**

Carte 16

**Que faire devant une VVP douloureuse et résistante à l'injection ?**

Carte 17

**Pourquoi ne pas banaliser une infection locale sur cathéter ?**

Carte 18

**Pourquoi préparer le soin avant de commencer ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 14

Son indication réelle et les alternatives. Un dispositif sans bénéfice prolonge une exposition évitable.

### Carte 13

Elles interrompent des maillons différents. Aucune mesure isolée ne compense toutes les autres défaillances.

### Carte 16

Ne pas forcer, évaluer et alerter. Ces anomalies imposent de rétablir une administration sûre.

### Carte 15

Douleur, rougeur, gonflement, fuite et fonctionnement inhabituel. Les signaler permet une évaluation précoce.

### Carte 18

Pour limiter interruptions et croisements propre-sale. Chaque contact peut créer une nouvelle indication d'hygiène des mains.

### Carte 17

Une diffusion sanguine et des localisations à distance sont possibles. La surveillance et l'alerte précoces comptent.

## Questions — rectos

Carte 19

**La vaccination dispense-t-elle des précautions standard ?**

Carte 20

**Comment distinguer bactéricide et bactériostatique ?**

Carte 21

**Quelles informations transmettre sur une VVP anormale ?**

Carte 22

**Un délai prévu suffit-il à garantir la sécurité d'un cathéter ?**

Carte 23

**Quelle est la portée des précautions standard ?**

Carte 24

**Quelles trois questions poser avant de choisir une protection ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 20

Le premier tue, le second inhibe la multiplication bactérienne. Ces effets dépendent des conditions considérées.

### Carte 19

Non. Elle apporte une protection spécifique et complète les autres mesures.

### Carte 22

Non. La surveillance et la nécessité du dispositif restent à réévaluer en continu.

### Carte 21

Les signes, leur apparition et les actions effectuées. Des faits précis soutiennent l'évaluation de l'équipe.

### Carte 24

Le soin, l'exposition et le circuit. Ces éléments guident une protection adaptée.

### Carte 23

Tout patient, tout soin et tout lieu. Elles s'adaptent au risque prévisible du geste.

## Questions — rectos

### Carte 25

**Quels sont les deux moments « avant » et le moment « après exposition biologique » ?**

### Carte 26

**Pourquoi réaliser une hygiène des mains après l'environnement du patient ?**

### Carte 27

**Quels prérequis retenir pour les mains avant les soins ?**

### Carte 28

**Quelles conditions rendent une FHA correctement réalisable ?**

### Carte 29

**Quelles trois zones vérifier pendant la friction des mains ?**

### Carte 30

**Une FHA reste-t-elle suffisante après un contact avec le téléphone ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 26

Les surfaces peuvent contaminer les mains. Le patient n’a pas besoin d’avoir été touché directement.

### Carte 25

Avant contact patient, avant geste aseptique et après risque biologique. Les moments se répètent selon la séquence.

### Carte 28

Mains visiblement propres et sèches, surfaces couvertes et durée respectée. Frictionner jusqu’au séchage complet.

### Carte 27

Avant-bras dégagés, ongles courts sans vernis ni résine et absence de bijoux. La technique doit atteindre toutes les zones.

### Carte 30

Pas pour le geste aseptique suivant. Ce contact peut recontaminer les mains.

### Carte 29

Pouces, espaces interdigitaux et pulpes avec ongles. Une couverture complète dépend aussi des mouvements.

## Questions — rectos

Carte 31

**Quel principe détermine le port de gants non stériles ?**

Carte 32

**À quels moments changer ou retirer les gants ?**

Carte 33

**Quand un gant stérile perd-il sa stérilité ?**

Carte 34

**Comment choisir entre tablier et surblouse ?**

Carte 35

**Quelles protections prévoir contre une projection biologique au visage ?**

Carte 36

**Quels trois réflexes associer face à une toux ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 32

Après la tâche, entre patients et du sale vers le propre. Leur maintien peut déplacer la contamination.

### Carte 31

L'exposition prévisible, notamment biologique ou à une muqueuse. Le diagnostic seul ne constitue pas l'indication.

### Carte 34

Selon l'étendue et l'intensité de l'exposition. La protection se retire à la fin de la séquence prévue.

### Carte 33

Lors d'un contact non stérile. Il faut rétablir les conditions d'asepsie avant de poursuivre.

### Carte 36

Masque adapté, mouchoir ou haut du bras et hygiène des mains. Ils limitent émissions et transfert par contact.

### Carte 35

Un masque et une protection oculaire adaptés. Les lunettes de vue ne remplacent pas une protection de soin.

## Questions — rectos

### Carte 37

**Quels trois moyens matériels ou organisationnels préviennent les AES ?**

### Carte 38

**Quelle priorité associer aux premiers soins d'un AES ?**

### Carte 39

**Quels principes sécurisent linge sale et prélèvements ?**

### Carte 40

**Pourquoi ne pas classer tous les déchets de soins en DASRI ?**

### Carte 41

**Pourquoi la douchette ne remplace-t-elle pas le traitement des bassins ?**

### Carte 42

**Quelle conduite tenir si le matériel de traitement des excreta est indisponible ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 38

Contacter sans délai le circuit médical prévu. Un éventuel traitement post-exposition est urgent.

### Carte 37

Collecteur proche, remplissage respecté et dispositifs sécurisés. Éviter les manipulations d'aiguilles usagées.

### Carte 40

Leur nature et leurs risques diffèrent. Les perforants, médicaments et produits chimiques suivent les filières prévues.

### Carte 39

Conditionnement adapté et séparation du propre et du sale. L'extérieur des contenants doit rester maîtrisé.

### Carte 42

Signaler et utiliser l'alternative validée. Une panne ne justifie pas une procédure contaminante improvisée.

### Carte 41

Elle disperse les souillures sans garantir le traitement. Employer le circuit d'excreta prévu.

## Questions — rectos

Carte 43

**Quel est le rapport entre PS et précautions complémentaires ?**

Carte 44

**Quels trois éléments organiser en précautions contact ?**

Carte 45

**Un patient en précautions contact peut-il quitter sa chambre pour un soin ?**

Carte 46

**Une BMR est-elle nécessairement plus virulente ?**

Carte 47

**Un portage de BMR équivaut-il à une infection ?**

Carte 48

**Que signifient EPC et ERG ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 44

Chambre et sanitaires, matériel, information des équipes. Ils complètent les mains et les protections adaptées.

### Carte 43

Les secondes s'ajoutent aux premières. Elles ne remplacent pas le socle de tous les soins.

### Carte 46

Non. La multirésistance concerne les antibiotiques, pas automatiquement la virulence ou la FHA.

### Carte 45

Oui, avec un déplacement organisé. Mains, tenue, lésions et information de l'accueil doivent être adaptés.

### Carte 48

Entérobactérie productrice de carbapénémase et entérocoque résistant aux glycopeptides. Ce sont des exemples centraux de BHRe.

### Carte 47

Non. La présence sans infection clinique n'impose pas à elle seule une antibiothérapie.

## Questions — rectos

Carte 49

**Comment une exposition antibiotique peut-elle sélectionner des résistances ?**

Carte 50

**Quel est le rôle d’un antibiogramme ?**

Carte 51

**Comment exploiter une alerte de résistance dans le dossier ?**

Carte 52

**Qu’est-ce qui conditionne la protection attendue d’un FFP2 ?**

Carte 53

**Comment distinguer isolement septique et environnement protecteur ?**

Carte 54

**Le nom Klebsiella pneumoniae impose-t-il des précautions air ?**

## Réponses — versos correspondants

**Carte 50**

Étudier la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. Son interprétation ne remplace pas le contexte clinique.

**Carte 49**

Elle défavorise les bactéries sensibles. Des résistantes peuvent persister puis diffuser.

**Carte 52**

Son indication et son ajustement correct. Filtrer ne suffit pas si l'air contourne le dispositif.

**Carte 51**

Lire le germe, le site, la date et les consignes. L'équipe d'hygiène aide à interpréter la situation actuelle.

**Carte 54**

Non. Le site, le mode de transmission et le contexte guident les mesures.

**Carte 53**

Limiter la diffusion depuis une personne ou limiter l'exposition d'un patient fragile. Les objectifs peuvent coexister.

## Questions — rectos

Carte 55

**Que signifie asepsie lors d'un soin ?**

Carte 56

**Sur quels supports réalise-t-on antisepsie et désinfection ?**

Carte 57

**Pourquoi la famille d'un antiseptique ne suffit-elle pas au choix ?**

Carte 58

**Deux présentations d'une même marque sont-elles interchangeables ?**

Carte 59

**Quels critères vérifier pour un antiseptique chez le nouveau-né ?**

Carte 60

**Comment clarifier une allergie dite « à l'iode » ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 56

Tissus vivants pour l'antisepsie, milieu inerte pour la désinfection. Les produits ne sont pas interchangeables.

### Carte 55

Empêcher l'introduction de micro-organismes dans le site protégé. Mains, matériel et technique participent ensemble.

### Carte 58

Pas automatiquement. Forme lavante, aqueuse et alcoolique peuvent avoir des usages différents.

### Carte 57

La formulation, la concentration et le site comptent aussi. Une même famille n'autorise pas tous les usages.

### Carte 60

Identifier le produit et la réaction puis faire évaluer. Fruits de mer et contraste ne prouvent pas toute allergie iodée.

### Carte 59

Âge, maturité cutanée, site et présentation. Une procédure spécifique évite de transposer celle de l'adulte.

## Questions — rectos

Carte 61

**Une peau propre est-elle déjà préparée pour tout geste invasif ?**

Carte 62

**Que faire avant l'antisepsie d'une peau visiblement souillée ?**

Carte 63

**Pourquoi respecter le séchage spontané d'un antiseptique ?**

Carte 64

**Peut-on compléter un flacon antiseptique déjà ouvert ?**

Carte 65

**Pourquoi désinfecter une valve avant sa manipulation ?**

Carte 66

**Que faire après une recontamination possible du site préparé ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 62

Nettoyer, rincer si nécessaire puis sécher. La souillure compromet les conditions de préparation.

### Carte 61

Non. La propreté visible ne remplace pas l'antisepsie lorsque le geste la requiert.

### Carte 64

Non, même avec le même lot. L'ouverture et la durée d'emploi doivent rester maîtrisées.

### Carte 63

Il fait partie de la méthode d'application. Essuyer ou souffler compromet les conditions du soin.

### Carte 66

Rétablir les conditions d'asepsie avant de poursuivre. L'absence de trace visible ne garantit pas la sécurité.

### Carte 65

C'est un point d'accès critique potentiellement contaminé. La méthode doit respecter le dispositif et le séchage.

## Questions — rectos

Carte 67

**Que signifie le symbole « deux barré » d'un dispositif ?**

Carte 68

**Quel site définit un DM non critique ?**

Carte 69

**Comment reconnaître la destination critique d'un dispositif ?**

Carte 70

**Que vérifier pour le retraitement d'un DM thermosensible ?**

Carte 71

**Pourquoi vérifier le spectre d'un produit de traitement ?**

Carte 72

**Pourquoi prétraiter un DM souillé immédiatement ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 68

La peau intacte. Le dispositif reste soumis à un entretien compatible avec son utilisation.

### Carte 67

Usage unique pour un patient. Son statut n'est pas modifié par un nettoyage ou une désinfection.

### Carte 70

Destination, notice et procédé validé, y compris pour les accessoires. La thermosensibilité seule ne suffit pas.

### Carte 69

Il accède à un tissu stérile ou au système vasculaire. Son traitement relève d'un circuit validé adapté.

### Carte 72

Pour éviter le séchage, réduire la charge et faciliter le nettoyage. Cela ne le rend pas prêt à l'emploi.

### Carte 71

Les agents n'ont pas la même résistance. Le procédé doit répondre à l'objectif dans ses conditions d'emploi.

## Questions — rectos

Carte 73

**Pourquoi le nettoyage précède-t-il le traitement final ?**

Carte 74

**Comment entretenir un appareil non immersible ?**

Carte 75

**Quels paramètres vérifier lors de la préparation d'un bain ?**

Carte 76

**Comment distinguer réduction logarithmique et assurance de stérilité ?**

Carte 77

**Que vérifier avant d'utiliser un matériel conditionné stérile ?**

Carte 78

**À quoi sert la traçabilité après traitement d'un DM ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 74

Par la méthode compatible prévue, souvent un essuyage adapté. Ni immersion ni pulvérisation directe ne s'improvisent.

### Carte 73

Les souillures peuvent faire obstacle au procédé. Le traitement doit atteindre toutes les zones requises.

### Carte 76

L'une décrit une diminution de population, l'autre une probabilité résiduelle. Ce ne sont pas deux comptages équivalents.

### Carte 75

Dilution, température, durée et état de la solution. Les valeurs sont propres au produit et au procédé.

### Carte 78

Retrouver dispositif, opérations et patient si nécessaire. Elle complète les contrôles sans remplacer le traitement.

### Carte 77

Intégrité, sécheresse, identification et péremption. La conservation dépend du conditionnement et du circuit.

## Questions — rectos

### Carte 79

**Quel est le but de la progression du propre vers le sale ?**

### Carte 80

**La marche en avant se limite-t-elle à l'ordre des chambres ?**

### Carte 81

**Pourquoi adapter le bionettoyage au secteur ?**

### Carte 82

**Un petit travail de maintenance peut-il exposer à des spores ?**

### Carte 83

**Pourquoi les travaux sont-ils préoccupants chez un patient immunodéprimé ?**

### Carte 84

**Que faire si un confinement de chantier est rompu ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 80

Non. Elle organise les flux pour empêcher le croisement du sale vers le propre.

### Carte 79

Éviter de recontaminer les zones traitées. La méthode doit maîtriser les flux et les outils utilisés.

### Carte 82

Oui. Le risque dépend des poussières produites, pas seulement de la taille ou durée du chantier.

### Carte 81

Activités, surfaces et vulnérabilité diffèrent. Une pratique locale ne devient pas une règle universelle.

### Carte 84

Éviter le passage exposant et signaler. Les barrières et circuits doivent être rétablis par l'organisation prévue.

### Carte 83

Ils peuvent disperser des spores inhalées. Le terrain favorise notamment des infections fongiques invasives graves.

## Questions — rectos

### Carte 85

**Quelles trois voies d'exposition à une eau contaminée distinguer ?**

### Carte 86

**Quelle exposition respiratoire relie eau et légionellose ?**

### Carte 87

**Quels trois facteurs surveiller dans un réseau d'eau ?**

### Carte 88

**Une purge suffit-elle à lever une restriction sur l'eau ?**

### Carte 89

**Que transmettre face à une anomalie d'eau ?**

### Carte 90

**Quel risque immédiat ajoute un traitement thermique du réseau ?**

## Réponses — versos correspondants

**Carte 86**

L’inhalation d’un aérosol contaminé. Cela ne préjuge pas des autres usages autorisés de cette eau.

**Carte 85**

Digestive, respiratoire par aérosol et contact cutanéo-muqueux. L’usage et le terrain déterminent la prévention.

**Carte 88**

Non. La remise en service dépend des mesures et contrôles prévus, pas du seul écoulement.

**Carte 87**

Stagnation, dépôts et températures favorables. La maîtrise du réseau doit être organisée et contrôlée.

**Carte 90**

La brûlure par eau chaude. Informer, sécuriser les points et attendre une remise en service autorisée.

**Carte 89**

Aspect, température, débit et point concerné. Des observations précises permettent une évaluation du réseau.

## Questions — rectos

### Carte 91

**Après un soin sale, comment accéder au matériel propre ?**

### Carte 92

**Quels temps précèdent l'administration sur une VVP en place ?**

### Carte 93

**Quelle étape démarre immédiatement après usage d'un endoscope ?**

### Carte 94

**Pourquoi classer séparément l'endoscope et ses accessoires ?**

### Carte 95

**Que signifie l'absence d'alerte informatique chez une personne qui tousse ?**

### Carte 96

**Quel point vérifier avant d'introduire du matériel chez un patient protégé ?**

## Réponses — versos correspondants

**Carte 92**

Mains, désinfection de l'accès, évaluation et rinçage prévu. Une voie déjà posée reste un accès à protéger.

**Carte 91**

Retirer les gants puis réaliser l'hygiène des mains requise. Traiter aussi les surfaces éventuellement contaminées.

**Carte 94**

Leur destination et leur statut peuvent différer. Un accessoire ne reprend pas automatiquement le circuit de l'appareil.

**Carte 93**

Le prétraitement selon sa procédure. Il prépare le nettoyage sans remplacer les étapes suivantes.

**Carte 96**

Son entretien compatible et les consignes de l'unité. Les EPI ne désinfectent pas l'objet introduit.

**Carte 95**

Elle n'exclut pas un risque. Les signes et le contexte guident les mesures initiales et leur réévaluation.

## Questions — rectos

Carte 97

**Que faire d'un sachet stérile tombé au sol avant le soin ?**

Carte 98

**Quels trois axes croiser avant un soin invasif ?**

Carte 99

**Pourquoi vérifier l'activité sur les virus nus ?**

Carte 100

**Pourquoi adapter les précautions contact à l'agent concerné ?**

Carte 101

**Quand mettre le FFP2 si des précautions air le requièrent ?**

Carte 102

**Quel contact caractérise un dispositif semi-critique ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 98

Patient et site, geste et produit, dispositif et circuit. La sécurité dépend de leur cohérence.

### Carte 97

L'écarter et suivre la procédure de remplacement. L'apparence ne suffit pas à garantir la stérilité conservée.

### Carte 100

Spores, parasites et bactéries n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les mains, produits et circuits suivent les consignes spécifiques.

### Carte 99

Ils peuvent être plus résistants à certains procédés. Le spectre du produit doit correspondre à l'objectif.

### Carte 102

Une muqueuse ou une peau non intacte. Son traitement dépend ensuite du dispositif et du circuit validé.

### Carte 101

Avant l'entrée, avec ajustement correct. La protection doit précéder l'exposition.

## Questions — rectos

Carte 103

**Quelle différence retenir entre Pontiac et maladie des légionnaires ?**

Carte 104

**Un filtre terminal autorise-t-il tous les usages de l'eau ?**

## Réponses — versos correspondants

### Carte 104

Non. Adaptation, échéance, terrain et usages autorisés restent à vérifier.

### Carte 103

Forme non pneumonique bénigne et pneumonie potentiellement grave. Le terrain contribue à la gravité.